Dr. Henrique Lacerda Moraes, CRM/MS 99.512
Alergia e Imunologia, adulto e infantil. Rua das Acácias, 120, Centro

RELATÓRIO MÉDICO COMPLEMENTAR

Justificativa para tratamento com omalizumabe. 20/04/2026

Paciente: Valdirene Sousa Prado. **Idade:** entre 40 e 50 anos. **Diagnóstico:** Urticária Crônica Espontânea (UCE), CID-10 L50.1.

Declaro que a paciente está em acompanhamento médico especializado por Urticária Crônica Espontânea, doença inflamatória crônica com episódios recorrentes de urticas e/ou angioedema, com importante repercussão clínica e sobre a qualidade de vida.

A doença está ativa e inadequadamente controlada, apesar do tratamento convencional otimizado. Foi feito tratamento com anti-histamínico H1 de segunda geração (bilastina) em dose quadruplicada, por mais de quatro meses, sem controle satisfatório, o que caracteriza falha terapêutica ao tratamento de primeira linha. Atualmente: UAS7 (Urticaria Activity Score, 7 dias) de 28 pontos, atividade clinicamente significativa; UCT (Urticaria Control Test) de 0 pontos, ausência de controle da doença. Diante disso, a paciente tem indicação médica de omalizumabe, conforme a estratégia terapêutica atualmente empregada para UCE refratária.

Da necessidade do tratamento

O omalizumabe é anticorpo monoclonal anti-IgE com indicação terapêutica estabelecida para UCE em pacientes que seguem sintomáticos apesar dos anti-histamínicos H1. A própria Nota Técnica do NATJus deste caso reconhece que o omalizumabe é a segunda linha terapêutica para esses pacientes, que tem registro ativo na ANVISA e que a UCE está entre suas indicações. Não se trata, portanto, de medicamento experimental nem de tratamento sem indicação para a doença da paciente.

Da questão referente ao SUS e ao CID

A indicação médica e sanitária do medicamento não se confunde com sua incorporação ao SUS para determinada doença. A paciente tem diagnóstico documentado de UCE (CID-10 L50.1), e não é médica nem tecnicamente admissível substituir ou criar diagnóstico diferente apenas para viabilizar o enquadramento administrativo. A Nota Técnica reconhece que o omalizumabe está incorporado para outra indicação, a asma; a questão, portanto, é de não incorporação específica para UCE, e não de falta de registro, de indicação ou de caráter experimental.

Da imprescindibilidade no caso concreto

A necessidade decorre da resposta inadequada ao tratamento convencional e da atividade significativa da doença, demonstrada por UAS7 de 28 pontos e UCT de 0 pontos. A doença

sem controle mantém prurido, urticas e angioedema, prejudica o sono, as atividades cotidianas e a qualidade de vida, e pode exigir tratamentos sistêmicos de resgate repetidos. O uso crônico de corticosteroides sistêmicos não é alternativa adequada para o controle contínuo da UCE, pelos riscos da exposição prolongada. Considerando a falha documentada do anti-histamínico H1 em dose quadruplicada e a ausência completa de controle, o omalizumabe é, neste momento, tratamento necessário, sem justificativa clínica para substituí-lo por tratamento ineficaz para o quadro.

Conclusão

A paciente tem UCE ativa e não controlada, apesar de tratamento adequado com anti-histamínico H1 de segunda geração em dose quadruplicada, com UAS7 = 28 e UCT = 0. Reitero a indicação de omalizumabe 300 mg por via subcutânea a cada 4 semanas, com acompanhamento clínico periódico e avaliação objetiva da resposta por UAS7 e UCT. Solicito que a necessidade do tratamento seja analisada pelas características clínicas individuais da paciente, independentemente da incorporação específica dessa indicação nas políticas de fornecimento do SUS.

Dr. Henrique Lacerda Moraes
Médico, Alergia e Imunologia, CRM/MS 99.512 (assinado digitalmente em 20/04/2026)